

Análise das Implicações do Princípio do Tratamento Nacional (TN) no Setor de Saúde e nos Serviços Financeiros

Autor: Pedro Paulo Henrichs Neto

Instituição: IDP

Curso: Mestrado em Relações Internacionais

Disciplina: Negociações Internacionais: Tópicos Avançados - Serviços, Investimentos, Compras Públicas e Comércio Digital

Professor: Henrique Martins Sachetm

RESENHA CRÍTICA

Resumo

O princípio do Tratamento Nacional (TN), previsto no Acordo Geral sobre Comércio de Serviços (GATS) da Organização Mundial do Comércio (OMC), estabelece que prestadores de serviços estrangeiros devem receber tratamento equivalente ao dos nacionais, após sua entrada legal no mercado. Este trabalho analisa criticamente as implicações da aplicação do TN em dois setores estratégicos para o Brasil: saúde e regulação de serviços financeiros. Em ambos os casos, avaliam-se riscos, benefícios e modos de prestação distintos, com base em experiências práticas e aspectos regulatórios. Ao final, apresenta-se uma proposta de posicionamento estratégico do Estado brasileiro.

Palavras-chave: Tratamento Nacional; GATS; Saúde; Sistema Financeiro; Regulação; OMC.

1. Introdução

O Acordo Geral sobre Comércio de Serviços (GATS), firmado no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC) em 1995, estabelece regras multilaterais para o comércio internacional de serviços. Um dos seus princípios centrais é o Tratamento Nacional (TN), que obriga os países-membros a assegurarem aos prestadores estrangeiros as mesmas condições jurídicas e regulatórias garantidas aos prestadores locais.

A aplicação do TN, entretanto, não deve ignorar as especificidades de cada país nem os impactos sobre políticas públicas fundamentais, sobretudo em setores sensíveis como a saúde e os serviços financeiros. Este trabalho tem como objetivo analisar, criticamente, as implicações do TN em dois setores estratégicos no Brasil, identificando riscos, benefícios e possíveis caminhos regulatórios.

2. Aplicação do Tratamento Nacional no Setor de Saúde

2.1 Planos de Saúde (Modo 3 – Presença Comercial)

A entrada de operadoras internacionais, como Allianz, Bupa e UnitedHealth, intensifica a competição e pode representar um risco à sustentabilidade do Sistema Único de Saúde (SUS). A tendência à oligopolização e o aumento de preços colocam em risco o equilíbrio do sistema público, enquanto a ausência de exigências sociais contribui para a evasão fiscal.

Proposta: estabelecer contrapartidas sociais obrigatórias, como a destinação de parte dos lucros ao financiamento do SUS e o estabelecimento de limites à concentração de mercado.

2.2 Hospitais Privados (Modos 2 e 3 – Consumo no Exterior e Presença Comercial)

A aquisição de hospitais por fundos estrangeiros gera preocupações quanto à padronização mercantil da saúde, ao aumento de custos e à degradação da qualidade do atendimento. Ao mesmo tempo, o consumo de serviços médicos por brasileiros no exterior (modo 2) aprofunda as desigualdades sociais e compromete a coesão do sistema público.

Proposta: vincular a operação de grupos estrangeiros a exigências regulatórias e cotas obrigatórias de atendimento pelo SUS; fomentar a internacionalização do SUS em regiões de fronteira mediante acordos binacionais.

2.3 Telemedicina e Plataformas Digitais (Modo 1 – Transfronteiriço)

A prestação de serviços remotos por empresas estrangeiras, sem regulação nacional, representa um risco para a segurança sanitária e a integridade do atendimento. A atuação de plataformas digitais sediadas fora do Brasil foge à fiscalização da ANVISA e do Conselho Federal de Medicina (CFM).

Proposta: exigir registro nacional obrigatório e conformidade com as normas técnicas brasileiras para todas as operações de saúde digitais, com previsão de bloqueio de serviços não regulamentados.

3. Aplicação do Tratamento Nacional em Serviços Financeiros

3.1 Bancos e Instituições de Crédito (Modo 3 – Presença Comercial)

A presença de bancos estrangeiros, como o Santander, já é consolidada no Brasil. A abertura irrestrita pode, por um lado, fomentar concorrência e diversificar produtos; por outro, comprometer políticas públicas de fomento ao desenvolvimento e à inclusão bancária, como linhas de crédito subsidiadas.

Risco: desregulação de tarifas, perda da capacidade de indução econômica pelo Estado.

Proposta: manter exigências prudenciais específicas e garantir a plena supervisão pelo Banco Central do Brasil.

3.2 Fintechs e Serviços Digitais de Pagamento (Modos 1 e 3)

Plataformas como Stripe, PayPal e Revolut oferecem serviços financeiros digitais sem sede no Brasil. Essa entrada desregulada reduz a competitividade das empresas nacionais e enfraquece os mecanismos de controle fiscal e monetário.

Riscos: evasão fiscal, lavagem de dinheiro e instabilidade cambial.

Proposta: obrigatoriedade de presença jurídica no país e cumprimento das diretrizes regulatórias do Banco Central e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).

3.3 Seguros e Resseguros (Modos 3 e 4 – Presença Comercial e Movimento de Pessoas Físicas)

A participação estrangeira no mercado segurador exige vigilância regulatória para evitar a evasão de divisas e a vulnerabilização do consumidor. A entrada de profissionais estrangeiros (modo 4) também demanda critérios técnicos rigorosos.

Proposta: limitar a participação estrangeira em setores estratégicos como seguros agrícolas; exigir reinvestimento local e revalidação de títulos para profissionais estrangeiros, com domínio da língua portuguesa.

4. Considerações Finais:

A aplicação ampla e automática do princípio do Tratamento Nacional pode gerar consequências adversas para o Brasil, como:

- Redução da capacidade regulatória do Estado;
- Aumento das desigualdades no acesso a serviços essenciais;
- Desnacionalização de setores estratégicos;
- Exposição a riscos fiscais, cambiais e regulatórios.

Nesse contexto, recomenda-se que o Brasil adote uma postura estratégica e seletiva, alicerçada nos seguintes eixos:

1. **Reservas específicas no GATS** para setores sensíveis, assegurando flexibilidade regulatória;
2. **Contrapartidas obrigatórias** para prestadores estrangeiros, ligadas ao desenvolvimento local;
3. **Fortalecimento das capacidades regulatórias nacionais**, com investimentos em órgãos como ANVISA, CFM, Banco Central e SUSEP;
4. **Promoção de parcerias estratégicas e transferência tecnológica**, que reforcem a soberania nacional e evitem a substituição de competências internas.

Referências

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). Disponível em: <https://www.gov.br/ans/pt-br>.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa>.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Regulação de fintechs e instituições financeiras. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br>.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 5 out. 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. *General Agreement on Trade in Services – GATS*. Genebra, 1995. Disponível em: https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gatsqa_e.htm.

PINHEIRO, Roseni; TRAVASSOS, Claudia. O impacto da privatização e financeirização na saúde brasileira. *Revista Saúde em Debate*, Rio de Janeiro, v. 41, p. 85-95, 2017.

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP). Marco regulatório do mercado de seguros. Disponível em: <https://www.gov.br/susep>.